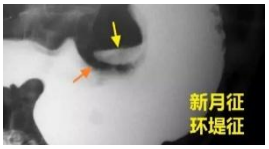
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

肿瘤本身无神经,侵犯到包膜神经可痛

（二）中老年、腹痛、体重减轻





①**内镜**：首选、金标准

②大便隐血试验筛查：可持续阳性 恶性肿瘤一直坏死出血

③CEA：判断预后、监测复发、辅助诊断 癌胚抗原无特异性,不用来诊断胃癌

④钡餐：胃壁僵硬、黏膜中断、不规则充盈缺损、壁内龛影、环堤征 VS良性胃溃疡:壁外龛影

比较有价值的诊断只有两个:①甲胎蛋白诊断肝细胞癌 ②前列腺特异抗原诊断前列腺癌

（三）治疗

1.D_2淋巴结清扫的根治性手术

①全胃切除术、远端/近端胃大部分切除术

②胃切断线距肿瘤边缘＞**5**cm，位于两端的癌切除食管下端或十二指肠 1 部的 **3-4**cm（无端生事）

③胃窦癌的远端胃大部分切除术（保留贲门+消化道重建选毕I或毕II式）**不清扫第 2、10 组淋巴结——贲门左 2、脾门 10 为胃窦癌的第三站**

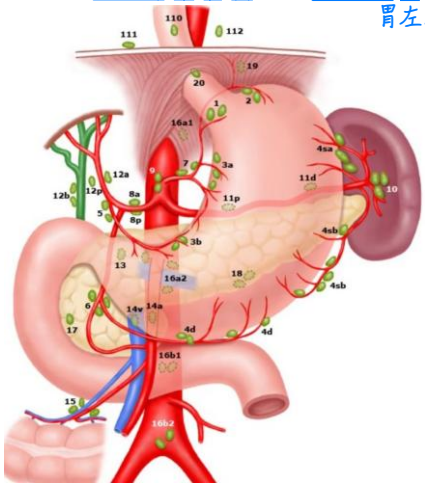
×脾动脉

④无论是全胃切除术、还是远端胃大部分切除术均**不清扫第 13-16 组淋巴结——胰头后、肠系膜上血管旁、结肠中血管旁、腹主动脉旁**（医生你牛——以后场上不请介种辅助）

×腹腔干

咏胃周淋巴结：1贲门右 2左 3小 4大弯、5幽门上 6下胃左肝（肝总A(8)）、腹腔动脉9脾门动（脾A(11)）10、13肝蒂胰后、14肠系膜、15结肠中、16腹主旁等

胃左A(7)　肝十二指肠韧带(12)



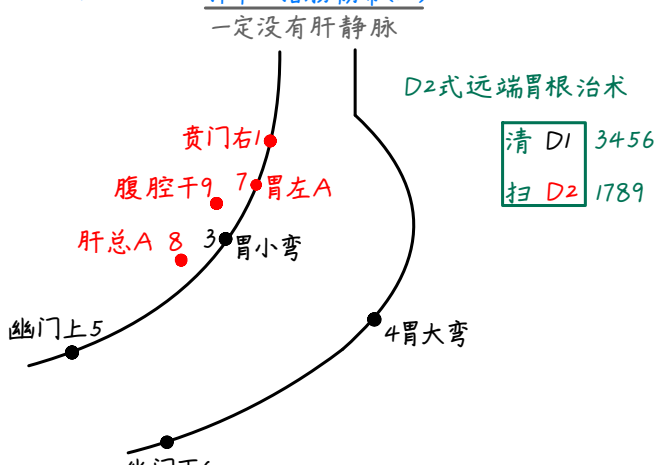




图 38-6　根治性远端胃切除术,Billroth Ⅱ式胃空肠吻合

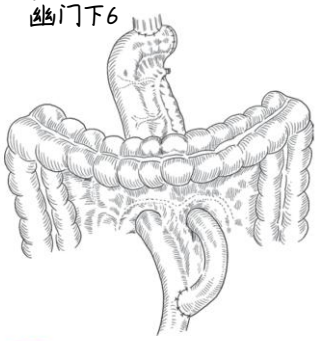


图 38-7　根治性全胃切除术,食管空肠 Roux-en-Y 吻合

2.其它治疗

①扩大根治术与联合脏器切除术：累及肝、脾、胰、横结肠等

②姑息性手术：原发灶无法切除而针对胃癌并发症（出血、穿孔、梗阻）

③化疗：氟尿嘧啶类 S-1 单药或联合顺铂（喂伯伯喝尿）

替吉奥　胃癌